第二章 全科医学的基本原则和全科医学教育

本章数字资源

学习提要

- 全科医学作为一门临床医学二级专业学科，具有独特的理论、知识和技能体系，全科医生在其临床服务中应遵守本学科的基本原则，体现学科的特质。全科医学的基本原则包括：以病人为中心照顾、以家庭为单位照顾、以社区为范围照顾、以预防为导向照顾、连续性照顾、综合性照顾、可及性照顾、协调性照顾、团队合作等 9 个基本原则，在本章学习中应掌握和理解这些基本原则的内涵，并能将其融入具体的患者照顾和健康问题管理中。
- 多国的经验和我国近四十年来全科医学教育研究与实践，已经证实较为完善的全科医学教育体系包括三个阶段的教育过程，即医学生的全科医学课程教育、毕业后全科医学教育、全科医生的持续职业发展教育暨全科医学继续医学教育。我国医学教育体系的基本框架与其他国家相同，但是在具体的全科医生培养方式上却与其他国家有所不同，我国医学教育体系中至今还存在临床医学专科教育，所以，我国全科医生的培养存在多种形式并存的现象，这也是由我们国家的特定国情决定的。

全科医学作为一门独立的临床二级专业学科，除具备临床医学一级学科所有特点，还有本学科自己的专业特点、基本理论和服务中应遵循的基本原则，其人才培养模式也与其他临床专业学科不同，必须在全科医学特定的专业基地进行规范的训练和培养，才能在国家卫生保健系统中起到“守门人”的作用。本章主要从全科医学的基本原则、全科医学教育体系和培养方式等方面进行阐述。

第一节 | 全科医学的基本原则

我国的全科医学自 20 世纪 80 年代后期引进至今，经过持续的探索与实践，在学科建设、人才培养以及全科医疗服务模式创建方面不断进步与发展。随着社会经济的发展，社区百姓对医疗卫生保健的服务需求也在不断变化和增长，要想在不同时期都能满足人们不断变化的卫生保健需求，就要研究在特定国情下，如何形成具有全科医学特色的适合我国社区人群的全科医疗服务模式。这就要求全科医学的教育者、学习者、研究者和广大全科医生要全面地了解全科医学学科的性质、特点和基本原则，用全科医学的基本原则指导临床实践，以展现全科医学专业服务特色，形成本学科的特定服务模式。此外，随着患者医疗卫生保健需求的变化，学习和了解全科医学的这些基本原则，对于从事其他临床专科工作也有一定的现实意义。

本节内容将在借鉴全科医学发展较为成熟国家教材的基础上，结合我国全科医疗实践探索的结果，将全科医学的基本原则进行概述，这些原则是指导全科医生提供临床服务的基本思想，也是提供服务的基本要素。

一、以病人为中心照顾的原则

以病人为中心的照顾（patient-centered care），又称为以人为本的照顾（personalized care）或者全

人的服务（whole-person care），是全科医学的重要原则之一，其与其他专科医疗以疾病为中心的诊疗模式有许多不同。

以病人为中心照顾的原则，其内涵包括以下几方面：①全科医学不仅重视患者所患疾病，更重视患病的人，将患者看作是有生命、有感情、有权利、有个人愿望和价值观的独特个体，而不仅仅是疾病的载体；患者与全科医生在人格上是平等的，他们只是因为患病而需要得到全科医生的理解和帮助。②全科医生要确立人的整体观，其服务目标不仅是要寻找到患病的器官和病因，还要把患者看作一个整体，不仅要关注患者的生理健康，还要关注患者的心理健康和社会适应方面的问题。③全科医生要根据患者的个体化特征提供服务。当全科医生面对一个具体的患者时，后者不仅具有大多数患者的共同特征，还具有其自身的个性化特征。如，同样是患有 2 型糖尿病，不同患者对疾病的担忧程度不同，对医疗服务的需求就会有差异：有的患者需要医生耐心解释病情，缓解其患病的焦虑；有的患者则需要具体化的健康指导，重塑对疾病的认知；有的患者会需要医生反复提醒，以建立其对疾病控制的重视等。因此，全科医生要善于从患者角度看待问题，除提供常规生物医学诊治措施，还要做到个体化和人性化，以维护患者的最佳利益为准则。④全科医生要善于调动患者的主观能动性，使其积极参与医疗活动。为此，全科医生在充分认识和理解服务对象的基础上，要通过良好的沟通，在制订诊疗计划时通过与患者协商，把患者的健康需求和价值观念融入临床照顾中，使其积极主动参与全科医疗服务，提高自我照顾的能力。

二、以家庭为单位照顾的原则

家庭是社会的基本单位，也是个体与社会的结合点。个体的疾病与健康不但与患者自身的身体条件、生活方式和环境因素有关，而且与家庭内部人员的关系及家庭本身对患者的治疗和康复意愿有重大关系。全科医疗与以医院为基础的其他专科医疗不同，素有关照患者家庭的历史，20 世纪 80 年代以来，越来越多的全科医生和社会工作者重视家庭因素和健康的关系。全科医学汲取了社会学家关于家庭的理论和方法，发展出了一整套以家庭照顾为核心的知识和技能，这表明全科医学非常重视家庭对健康的影响。目前，绝大多数国家的全科医学专业住院医师培训项目都会训练学员照顾各年龄段家庭成员的基本技能，家庭已成为全科医生开展诊疗工作的重要场所。这也是全科医学与其他专科医学的重大区别之一。

以家庭为单位照顾（family-oriented care）的原则，其核心要素包括以下三个方面：①全科医生要掌握家庭各种因素和家庭资源对健康和疾病发生、发展、传播、康复的影响及其作用机制。如，全科医生在为患者服务时，要考虑家族遗传因素和母亲孕期各种因素对胎儿/儿童健康的影响，适时地将易感家庭转给遗传病专家，做好早期预防和筛检服务，并能清楚地让家庭了解专家建议。②全科医生应及时了解患者家庭生活周期动态变化及其可能出现或者面临的健康问题，做好家庭生活事件的应对和心理调适，避免家庭危机。③全科医生要掌握家庭评估的基本方法，对特定家庭要掌握其家庭资源的状况，适时做好家庭内外资源的动员工作，促进患者及其家庭的健康。

三、以社区为范围照顾的原则

全科医疗是立足于社区的基层医疗服务，其主要实施地点是基层医疗卫生服务机构，包括社区卫生服务中心/站、养老院、托老所、临终关怀医院、患者家庭、功能社区等，主要体现了本社区的地域和人群特点。因此，全科医生有别于其他以医院为基础的临床医生，不仅要为患者提供一对一的个体性医疗服务，还要着眼于本社区全体居民的健康状况，包括就诊者和未就诊者，研究社区的健康问题及健康相关因素，制订针对性的卫生保健计划，做好特殊人群的服务，适时动用社区资源和组织力量加以执行和评价，从而改善社区内人群的健康状态。

以社区为范围照顾（community-oriented care）的原则，其核心要素包括以下四个方面：①全科医生不仅要照顾好个人化的患者，还要了解社区人文环境、经济状况、健康影响因素等，学习流行病学等

学科的知识和技能，具备社区群体健康的理念；要以该社区人群健康需求为导向，全科医疗服务的内容与形式应符合当地人群的需求；将全科医疗中个体和群体健康照顾紧密结合、互相促进。②全科医生要对个体患者身上反映出来的群体问题足够敏感。全科医生通过掌握门诊就诊患者的健康状况，来预估社区人群健康的基本状况，把握人群健康促进和健康宣教的重点；同时，也要通过社区诊断或者其他调查方式，掌握社区人群或重点人群的健康状况和健康危险因素，从而做好门诊针对性筛检和诊疗工作。③全科医生要熟悉社区诊断的基本思路与方法，通过了解社区诊断结果从而把握社区人群的健康状况和水平，根据实际作出社区干预计划，不断提高社区人群健康水平。④全科医生在做人群健康照顾时，要了解社区动员的潜力，包括居民的社会意识、社区权利结构及运用、社区居民对卫生事业的关心程度及社区人口素质与经济能力等。如，据社区 2 型糖尿病患者中不能遵医嘱定期检测眼底的患者反映，他们不做监测的原因是他们认为眼底病变与 2 型糖尿病控制不良关系不大；社区卫生服务机构不能做眼底检查，而去专科做眼底检查又给他们带来很多不便。了解这些原因之后，全科医生对于今后如何改进 2 型糖尿病患者并发症监测有了更有针对性的做法。

四、以预防为导向照顾的原则

在以疾病为中心的医疗服务模式下，医疗机构倾向于追求先进设备、全面检查和精确定位诊断，这使得医疗投入越来越多、分科越来越细、三甲医院就诊患者越来越多、应诊时间越来越短。在此模式下，医生更注重短时间内解决患者的现患疾病，无暇提供预防性服务（如指导患者如何进行自我保健等）。而在全科医学的以病人为中心的服务模式下，全科医生有充足的时间与患者接触，将预防性服务融入患者每一次的诊疗过程中，因此，在提供预防性服务方面具有明显的优势。

以预防为导向的照顾（prevention-oriented care）重点在于对服务对象整体健康的促进与维护，即在其健康时、由健康向疾病转化过程中以及疾病发生早期就主动提供一级预防、二级预防和三级预防。因此，全科医生的服务对象除了患者还包括高危人群与健康人群，这也是它有别于一般临床医疗的最突出的特点之一。

全科医生遵循以预防为导向照顾的原则，需要掌握以下几个核心内涵：①全科医生要了解疾病的自然史及其与预防医学措施的关系，从而做好个体化的预防保健工作。如，在疾病易感期（即健康人和高危人群），对于健康人，做好健康促进、膳食营养平衡指导、优生优育教育和健康维护；对于有危险因素存在的人，进行危险因素的监测与干预；对于处于临床征候前期的人，做好二级预防，通过筛检或定期健康检查，做好疾病的早期发现和积极的治疗，防止疾病蔓延；对于处于临床期的患者，要进行积极治疗，通过适当的转诊使患者得到妥善的治疗，避免疾病恶化和出现残疾；对于处于残障期的患者，要提供积极正确的康复服务；对于临终患者要做好临终关怀。②全科医生要利用好每一次与患者及其家庭接触的机会，提供针对性的预防保健服务（也称为“机会性预防”服务）。如，一位因普通感冒来就诊的女性患者，病历中记录其有皮肤癌家族史，所以在解决好感冒这一健康问题之后，继续询问患者近期皮肤在阳光下暴露的情况，并检查了皮肤上“痣”的颜色，测量了痣的大小等。③充分利用不同年龄、性别、人群的流行病学数据和疾病谱，积极开展健康教育、疾病筛检工作，将预防服务落实到日常医疗实践活动中。不论患者的年龄、性别和疾病类型如何，全科医生的服务计划都应包括顺延性和规划性的预防保健服务，并注重沿“人生命周期”“家庭生活周期”提供保健，根据其服务对象在不同的生命周期中可能存在的危险因素和健康问题，针对性地提供一、二、三级预防。④将以预防为导向的病历记录和健康档案作为患者健康照顾的基本工具。充分利用这一工具记录个人史、家族史资料，根据患者的年龄、性别、危险因素等特征选择适宜的预防项目，不断完善个人疾病预防服务计划，完善和落实周期性健康检查，对检查结果反映出的问题做出正确的处理。⑤建立针对人群的预防服务档案。一般根据具体的预防项目设计，如根据儿童免疫接种项目建立的儿童预防接种档案。此外，还有针对新生儿、孕妇、产妇、老年人等的预防项目。做到个人预防与群体预防相结合。如，全科医生为个人及家庭提供服务时，当发现某一问题在社区也广泛存在并且有流行倾向时，就不要仅停留

在对个人及家庭的预防上，而要在社区诊断的基础上，制订和实施社区预防计划，把提高全体居民的健康作为医疗服务的目标。

提供连续性、综合性、协调性、个体化的预防性服务。全科医生以病人为中心、以家庭为单位、以社区为范围、以预防为导向，提供预防、治疗、保健、康复一体化服务，其中预防服务是核心内容，在整个生命周期的治疗、保健和康复中起主导作用。全科医生是居民健康的“守门人”，其服务目标直接指向提高社区全体居民的健康水平，在社区层面上提供健康教育、健康促进等预防性服务，从而减少慢性病的发生和加重，改善居民的生活质量。

五、连续性照顾的原则

全科医学的临床服务是为所照顾的患者提供从生到死、从健康到疾病再到疾病康复的全过程服务，有人将其描述为“从摇篮到坟墓的服务”，这是全科医学区别于其他专业学科的主要特征之一。

全科医学的连续性照顾（continuity of care）的原则，可以从以下几个角度来理解：①沿着人的生命周期中各个阶段提供照顾。从婚育咨询开始，孕期、产期、新生儿期、婴幼儿期、少儿期、青春期、中年期、老年期直至濒死期，都可覆盖在全科医疗服务之下；当患者去世后，全科医生还要顾及其家属居丧期的保健，乃至某些遗传危险因素的连续性关照问题。②沿疾病的周期（健康-疾病-康复）的各个阶段提供照顾。全科医疗对其服务对象负有一、二、三级预防的不间断责任，从健康促进、危险因素的监控，到疾病的早、中、晚各期的长期管理。③无论何时何地，全科医生都对其服务对象负有连续性责任，要根据其需要事先或随时提供服务。

连续性照顾是全科医学区别于专科医疗的十分重要的原则。全科医生可通过一些特定的途径实现连续性照顾，如，建立预约就诊制度，以保证患者能够如约就诊，实现健康问题/疾病照顾的连续性。目前，我国正在推进家庭医生签约制度，社区居民与全科医生通过签约建立固定的医患关系，全科医生为签约患者提供长期照顾成为其工作的基本职责与服务内容。随着该制度的不断落实，在制度保障下，全科医生在服务中贯彻连续性照顾原则也会更加容易。此外，很多国家还通过研究人生命周期不同阶段常出现的健康问题和疾病，研究制订预防保健计划，全科医生可以根据本国研究制订的预防保健计划，做好疾病筛检、治疗和康复的服务工作，沿着人生命周期连续做好各不同年龄阶段人群的预防保健服务。

六、综合性照顾的原则

在全科医生接触的患者中，大多数患者面临的健康问题往往不是单一的，既包括急性问题，又包括慢性问题；既包括生理方面的问题，又涵盖心理、社会方面的问题；既可以是单器官受损，又可以涉及多器官、多系统。因此，患者需要的服务通常是整体性的，这就要求全科医生把患者看作一个整体，在全面了解患者的基础上，提供综合性照顾。

综合性照顾（comprehensive care）的原则，要求全科医生在服务中要体现出全科医学学科对人及其健康问题照顾的“全方位”或“立体性”的重要特征。具体体现在：①就服务对象而言，不分年龄、性别和患病类型；就服务内容而言，涵盖医疗、预防、康复和健康促进各个方面；就服务层面而言，涉及生理、心理和社会文化各个层面；②就服务范围而言，包括个人、家庭与社区，要照顾社区中所有的单位、家庭与个人，无论其在种族、社会文化背景、经济情况和居住环境等方面有何不同；③就服务手段而言，可利用对服务对象有利的各种方式为其提供服务，包括现代医学、传统医学或替代医学（alternative medicine）。因此全科医疗服务又被称为一体化服务（integrated care）。

七、可及性照顾的原则

全科医疗是社区居民在想利用时方便并且可得的基层医疗服务，服务的可及性是衡量全科医疗服务的一个重要指标。在实际提供服务的过程中，全科医学的可及性照顾（accessible care）的原则应

NOTES

体现在：全科医疗服务机构设置在居民区内，或者距离居民的生活区或者工作场所比较近；所提供的服务内容均符合或者满足社区居民的健康服务需求，也即使用方便；全科医生及其团队能与社区居民建立良好的医患关系；治疗有效；服务价格方面居民能够接受。全科医疗经过多年实践，已经证实在医患双方彼此信任、关系亲近且熟悉的情况下，全科医生在诊疗中可以大大减少不必要的实验室检查与辅助检查，从而获得比一般专科医疗更好的成本效益。

全科医疗服务机构一直向患者敞开大门，不会拒绝任何患者，永远是患者的第一救助者。全科医生擅于正确处理患者可能出现的常见病、多发病问题（约占 80% 的问题），这意味着社区居民就医时，总是能够及时得到全科医疗服务。可及性服务还包括方便的设施、可靠的医疗、稳定的关系、有效的预约、非工作时间的值班或咨询服务等。判断全科医疗服务是否具有可及性，可以从以下 5 个方面来衡量：一是服务距离上可及。如，某地区在设置社区卫生服务机构时，规定城市居民 15 分钟能够步行到达社区卫生服务中心/站，乡村地区居民要在半小时内步行到达。二是在服务设施设备配置和专业人员数量上可及。如，我国计划到 2030 年，城乡每万名居民拥有 5 名合格的全科医生，以更好地满足社区居民卫生保健需求；机构床位数、护士人数、基本的诊疗设备的功能和配置要满足解决社区常见问题的需要等。三是全科医疗服务机构所提供的服务内容可及，即全科医生所提供的服务内容能够满足当地社区居民基本医疗卫生保健需求，并能够提供适当的转诊服务。四是服务效果上可及，即通过全科医疗服务能够使患者的健康问题得到有效控制或治愈；患者对就诊具有良好的体验。五是经济上可及，即社区居民可以承担得起全科医疗服务所需的费用；全科医生也需要考虑合理使用医疗保障费用，在保证服务质量的同时节约费用。

八、协调性照顾的原则

协调性照顾（coordinated care）是指针对患者的要求而对保健服务进行的调整、组合过程。协调性照顾需要全科医生关注患者健康需求的各个方面，包括协调性地提供预防性服务、健康监护、健康促进和健康教育服务。

为实现对服务对象的全方位、全过程服务，全科医生作为患者和提供医疗卫生服务者之间的协调人，是动员各级各类资源服务于患者及其家庭的枢纽。全科医生首先需要掌握患者的健康状况，同时也要掌握各类专科医疗的信息，包括拟将患者转诊给其他专科医生，该医生的专业特长和服务水平，还要具有掌握各会诊专家信息的特定专业能力，患者需要时可为其提供全过程“无缝式”的转诊和会诊服务；全科医生熟悉社区内与诊疗和康复有关的资源，如社区内其他医疗机构等医疗资源、转诊患者的最优路线、社区组织及其功能、患者小组、志愿者队伍、养老机构、营养食堂、护工队伍等，必要时可为患者联系有效的社区支持；全科医生还要熟悉患者及其家庭，对家庭资源的把握与利用是全科医生不可缺少的基本功。上述各种健康资源的协调和利用使得全科医生能够胜任“健康代理人”的岗位，为患者及其家庭提供有效的医疗保健服务。

九、团队合作的原则

团队合作（team work）指的是一群有能力、有信念的人，在特定的团队中，为了一个共同的目标凝聚在一起，相互支持、奋力合作的过程。它可以调动团队成员的所有智慧与能力，减少甚至驱除所有不和谐和不公正的现象，回报给大公无私的奉献者以适当的利益。

在全科医疗发展初期，全科医生多以个人执业的形式在社区为居民提供服务。随着社会的发展，社区居民的健康服务需求也发生了重大变化，人们对全科医疗服务的内容和质量都提出了新的要求，个人执业的人力和技术难以适应，为了应对患者多方面的服务需求，也为了谋求更好的生存和发展，各国全科医疗都走上了团队合作的道路，逐渐形成了适合本国的全科医疗团队合作工作模式。

全科医疗团队一般是以全科医生为核心，根据所照顾患者健康和疾病的情况，有计划地组织工作团队，本机构团队中通常包括全科医生、社区护士、公共卫生医师、营养师、心理医生、康复师、社会工

作者、其他专科医师等。全科医生根据照顾患者的需要，还会请上级的专科医生参与患者所患疾病的照顾，患者家属有时也是患者照顾团队中的基本成员之一，一起为服务对象提供立体网络式的健康维护和疾病管理，这对促进社区居民健康具有十分重要的作用。此外，在基层医疗机构与各级各类医疗保健网之间，也存在着双向转诊和继续医学教育的团队合作关系。因此，全科医生要将自己作为卫生保健系统中的重要组成部分，善于运用人际交往技巧，与社区内外各类人员建立有效的合作关系，协调和调动各类可利用的医疗资源和非医疗资源参与全面的患者照顾服务。

目前，随着我国家庭医生签约制度的不断推进，在很多社区都尝试组建由不同人员组成的以全科医生为核心的家庭医生签约服务团队，如由全科医生、社区护士、预防保健医师组成“医-护-防”团队，也有的社区卫生服务机构组建了“全科医生-社区护士-预防保健医师-社区工作者”四人小团队等。随着我国分级诊疗制度和家庭签约制度的进一步落实，各地全科医疗机构还会与时俱进，进一步研究和探索全科医生团队的架构和服务模式，更好地满足照顾患者的需求，社区居民也会在接受服务的过程中有更好的就医体验。

第二节 | 全科医学教育

20 世纪 50 年代后期，在西方经济发达国家，慢性病、退行性疾病逐渐成为影响国民健康的主要问题，一些国家开始对已经在基层执业的通科医生进行再培训，以提高他们的服务能力和服务水平。到了 20 世纪 60 年代，在一些医学院校开始建立全科（家庭）医学学系，针对想从事基层医疗服务的临床医学专业毕业生，尝试开展为期 3~4 年不等的毕业后教育，即全科医学住院医师培训；参加培训的住院医师在完成培训项目之后，通过全科医师专科学会组织的执业资格考核，取得全科医师的执业资格，注册之后就可以从事全科医疗服务。与此同时，为了吸引优秀的医学毕业生在毕业后能够选择接受全科医学住院医师培训，在医学生中开始设置全科医学的相关课程。为了保证培训合格的全科医生具备持续的岗位胜任能力，各国陆续为执业中的全科医生开发继续医学教育项目，对全科医生开展继续医学教育。1994—1995 年世界卫生组织和世界家庭医生组织（WONCA）共同发文提出：“医学院校应继续改进其使命、战略计划、招生政策、师资构成、课程设置、考试方法和训练场所，以适应毕业生服务社区居民的需要”，要求世界各国在 21 世纪都要逐步建立全科医学教育培训体系，在医学院校要建立全科医学学系，为医学生开设全科医学课程。此后，很多国家对全科医生队伍建设更加重视，全科医学教育体系逐渐在各国建立和完善。目前世界上许多国家都建立了较为完善的全科医学教育体系，设立了全科医学专业人才培养标准、考核与注册制度。随着各国全科医学教育体系的不断完善，全科医生队伍得到发展壮大，推动了很多国家全科医学学科的快速发展。

我国从 20 世纪 80 年代后期引入全科医学概念开始，就在少量的不同层次的医学院校中探索全科医生的培养方式。经历了近 40 年的探索与实践，目前我国全科医学教育体系已经形成。从全国范围来看，全科医学教育的主要形式包括：高等院校医学生的全科医学课程教育、毕业后全科医学教育（全科专业住院医师培训或称规范化培训、全科医学研究生教育）、全科医生持续职业发展教育/继续医学教育等。

一、国外全科医学教育体系

全科医学教育在国外起步较早，大多数国家都建立了国家级的全科医生规范化培训项目，有严格的导师带教制度与考核制度，逐步形成由全科医学院校教育、毕业后全科教育和全科医学继续教育三个教育过程组成的较为完整的教育体系。

在国外，有些国家为了培养全科医生在科学研究、临床服务和教学方面的专长和能力，还开设了全科医学研究生培训项目，或设立了全科医学专业会员资格培训项目。从目前世界各国培养全科医生的主要途径来看，毕业后教育暨全科医学住院医师培训，是培养全科医生的主要方式。

NOTES

（一）医学院校中医学生的全科医学教育

在国外，如美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本、新加坡、以色列等许多国家的医学院校都设有全科医学教学机构，并在医学生中开设全科医学课程教育。全科医学教学在医学院中的开展，可吸引很多医学生在毕业后进入全科专业住院医师培训项目，即进入毕业后全科医学教育项目，推动了全科专业住院医师培训项目的发展，也促使进入基层卫生服务系统执业的全科医生数量的增加。

1. 教育目标　针对医学院校中的医学生，全科医学教育的目标并不是培养一位合格的全科医生，而是让他们了解全科医学学科的性质、任务和服务方式，培养他们对全科医学的兴趣，希望他们毕业后能选择全科医学作为自己的终生职业；另外一个目的是使医学生早期接触全科医生的工作环境和工作内容，以及职业发展路径。

2. 课时安排　各国医学院校开展全科医学教育的时间有所不同，一个国家内部的医学院之间开展全科医学教育的时间也不尽相同，但一般在 4~10 周左右。各国全科医学教育形式各异，有的国家如澳大利亚、以色列等对医学生开设连续性的全科医学课程，学生在不同的学期内可以接受不同地域、各具特色的全科医学教育，有的学期仅开设全科医疗门诊见习课程。

3. 教学内容与方式　在医学生中开展全科医学教育的内容多集中在全科医学的基本概念与基本理论、全科医疗服务的特点、全科医生的诊疗模式、医患沟通技巧等。对医学生开展全科医学教育的形式分为必修课和选修课，不同国家和地区开设相关课程的阶段不同，但更多的院校是在临床见习或者实习阶段开设。教学的方式多选择在全科医疗诊所进行见习或实习，也有在医学生低年级阶段为其开设全科医疗诊所见习、患者家庭随访等实践课程的；多数医学院校偏重于早期接触全科医疗实践教学，通常在开展少量的全科医学理论教学的基础上，进行全科医疗中常见健康问题/疾病的案例讨论，课程考核的形式也是多样性的，重视学生参与课程的过程质量。

（二）毕业后全科医学教育

从目前毕业后全科医学教育的现存形式来看，毕业后全科医学教育主要包括全科医学住院医师培训和全科医学硕士研究生培养两个类型。

1. 全科医学住院医师培训　全科医学住院医师培训（residency training program on general practice）是毕业后全科医学教育（postgraduate training program on general practice）最主要项目，在国外通常把毕业后全科医学教育等同于全科医学住院医师培训，在英国又将其称为全科医学的职业培训（vocational training program on general practice）。在国外，很多国家都建立了专科医师制度，制度要求医学生在毕业后必须经过相应专业的专科医师培训才能获得专科医师的培训合格证书，然后才可以注册并开始行医。

全科医学住院医师培训是培养合格全科医师的主要途径，是全科医学教育体系的核心。在国外，该类培训项目多由大学的全科医学学系负责学员招募和组织实施，而用来判定训练是否合格的人才出口标准多由国家级全科医学专业学会或协会来考核和认证。全科医学住院医师训练场所，包括能够训练临床诊疗技能的大型综合性医院相关临床科室、能够训练全科医学诊疗思维能力和服务能力的社区全科医疗诊所等专业机构。

（1）培训目标：全科医学住院医师培训的目标由以下五个方面组成：一是与应诊相关的各种知识、技能和态度；二是与服务的具体情境相关的目标，包括考虑个人的生存环境、医疗资源和服务体系的利用、医疗服务的成本效益原则等；三是与服务的组织相关的目标；四是与职业价值观和性质相关的目标，包括全科医生应具备的态度、价值观和责任等；五是与全科医生业务发展相关的目标，包括终身学习能力、自我评价能力、参与适当的教学和研究、医学信息的批判性阅读与利用等。

（2）培训的时间：各国全科住院医师的培训时间长短有所不同，绝大多数国家的培训时间是在 3~4 年之间。加拿大全科医学住院医师培训的时间仅为 2 年，为农村地区培养的全科医生的培训时间需要加长至 3 年；以色列的培训时长为 4 年，其中社区全科医疗实践的培训时间占总培训时间的一半左右，这与其他国家是不同的。

（3）培训的方式与内容：①医院相关临床科室轮转，通常占培训总时长的 2/3。②社区全科医疗实践，一般占总时长的 1/3。目前多数国家将社区全科医疗实践与临床轮转交叉进行培训，但也有国家如以色列，把全科医疗实践的时间安排在医院科室轮转的前后，分别进行。随着社区人群疾病谱的改变和人们对全科医疗服务需求的增加，全科住院医师培训的时间安排也越来越向社区全科医疗实践倾斜，全科医疗实践的总时长也在适当增加，重点提高全科医生岗位胜任能力，对于减少轮转时间或根本不再轮转的科室，则通过特定的继续医学教育项目来加强临床知识和能力的培训。③疾病和临床问题小组讨论或学习，穿插在整个住院医师训练项目的全过程之中，通常由住院医师的指导教师组织，每周 1~2 个半天，必要时会邀请其他学科的教师共同参与指导。

全科医学住院医师培训的内容是围绕上述培训目标来设计的。培训内容一般包括以下五个方面：一是与诊疗健康问题或疾病相关的人文社会科学知识和技能；二是诊疗各种常见疾病和健康问题所需的各种知识和技能；三是全科医学基本理念和基本知识，以及职业价值观和服务管理等相关的知识与技能；四是基本科学研究和医疗服务质量改进相关的知识和技能；五是与个人执业生涯相关的能力培养。

（4）考核：全科医学住院医师的考核，分为过程考核和终末期考核。过程考核分为在临床各科轮转结束时的出科考核和阶段性考核；终末期考核，一般是在完成全部培训内容且过程考核合格的情况下进行，一般是由国家级的全科医学专业学会/协会，或者专门的机构举办全国性的全科医师资格认证考试，通过该考试者可获得全科医师资格证书，获得证书的全科医师才可以受雇于医疗保险公司或医疗机构，注册后就可以从事全科医疗职业活动。

2. 全科医学研究生教育 全科医学研究生教育是毕业后全科医学教育的另外一种形式。在加拿大、美国、英国、新加坡、马来西亚等为数不多的国家曾经开展过，或一直在开展全科医学专业研究生教育，如加拿大多伦多大学就对全科医生开设了全科医学硕士学位课程。有些国家的全科医学研究生项目只招收全科医生身份的学生，将研究生教育定位在科研能力、某专项服务能力和领导力提升方面，一般不通过研究生教育培养合格全科医生。因为国际上医学教育体系的不同，很多国家的高等医学院校都没有设置全科医学研究生教育项目。

以下根据其他国家全科医学研究生培养模式进行概述。

（1）培养目标：培养学科业务骨干，培训全科医学教师，提高全科医生队伍研究能力。新加坡在很长一段时间内将研究生教育定位于既培养科研能力又培养临床服务能力，并将其作为全科医生培养的主要渠道之一。

（2）培养时间：研究生教育的时间多为 1~2 年。申请参加培训的人员多为培训合格的全科医生，或者拟成为全科医学教师者。

（3）教育内容：多以扩展全科医学的相关知识、技能和科研能力为主。如，加拿大多伦多大学的全科医学研究生项目，招收对象是国内外的合格全科医生，其他专业对全科医学研究有兴趣者也可以被招录，学习的时长和内容一致，主要提升全科医生科学研究的能力、教学能力和领导力等。

（4）教育形式：多以在职研究生课程班的形式进行全科医学研究相关的课程教学、研究论文和论文报告等。教育过程多实行“导师制或者导师小组制”，导师及其导师小组根据项目出口标准和培训要求，对学生进行督导；大学全科医学学系和研究生管理部门对培训过程和培训终末期质量进行监督和检查。

（三）全科医学的继续教育

全科医学继续教育（continuing education in general practice），又称全科医生持续职业发展教育（continue professional development）。继续教育是针对全科医生岗位能力要求与培训需求而开发的形式和内容多样化的培训项目，以保持和促进全科医生的职业水平，是全科医生接受终身教育的主要方式。

1. 培训目标 全科医学继续教育的目标，是通过接受持续的教育培训使全科医生的专业水平得到保持和提升，也可以根据社区人群的健康服务需求，通过继续教育项目发展专业特长。

2. 培训时间　跟其他类别专科医生一样，全科医学继续教育多依据国家或者国家中某地区卫生行政部门或者专业学会的相关规定，完成必修学时和选修学时的课程内容；有的专业学会还规定在不同年度必须完成哪些指定内容的学习任务。美国家庭医学委员会（ABFP）要求其家庭医生每 6 年必须参加 ABFP 的专业资格再认定考试，并且将取得相应继续医学教育学分作为该全科医生专业资格再认定报名考试的前提条件。英国全科医生的平均继续医学教育时间为 1 周/年。

3. 培训形式与内容　全科医学继续教育项目的设置，一般由全科医学专业学会或者协会根据国家卫生保健体系对全科医生岗位胜任力的要求、全科医生队伍对培训内容的需求和需要进行研究和确定，内容通常包括：与职业发展相关的理论培训讲座、临床服务技能提升培训班、参加各种级别的学术会议、在学术会议上做报告等。如，基层医疗中的伦理学原则、相关法律法规培训、相关疾病的临床指南应用、心脏生命支持、创伤生命支持、新生儿复苏程序、产科生命支持等，很多国家都支持全科医生参加本国或本地区，或世界其他国家举办的全科医学学术会议等，纳入统计全科医生参加继续教育获得继续学分的范畴。在全科医生继续教育项目中，行为科学、人文社会科学的内容大大超过了其他专科；流行病学概念与方法也得到突出强调。某些特定专业学科的知识和技能，也大多会受到全科医生的欢迎，如：老年医学、精神医学、急诊医学、临床营养学、运动医学、皮肤科学、康复医学、替代医学、心理咨询技术等。有些继续教育项目的开展可以通过全科医学专业学会与其他专科学会的共同合作来实现，全科医生也可以通过参加相应的继续教育项目获得专长服务资格证书。除了参加国家级、地区级、本机构级别的继续教育项目，有些全科医生还会根据自身服务能力提升需求，主动联系医院到临床某科室进修，或参与科室的查房或病例讨论等，也有一些全科医生或者一起工作的全科医生团队根据工作所需，进行针对性的自学，比如自学统计软件、临终患者心理支持等。

4. 学习要求　各国对全科医生参加继续教育的学习内容和获得学分的要求不尽相同，但很多国家都对全科医生参加继续教育的学分或者学习内容提出具体要求，以督促全科医生在繁忙的工作中，不断更新自身知识和理论，保持良好的岗位胜任能力。一些国家对全科医生接受继续教育内容和/或学分有强制性的要求，将学分与全科医生自身执业资格再注册相关。下面以美国、加拿大、澳大利亚全科医生继续医学教育学习的要求为例，了解国外全科医生继续教育与全科医生职业发展的重要关系（表 2-1）。

表 2-1　美国、加拿大、澳大利亚全科医生继续医学教育学习的要求

项目	学分评估时间	学分要求	培训内容与培训方式	强制与否
美国	每 6 年 1 个周期，是执业资格再注册的基本条件	1. 3 年内至少修满 150 学分 2. 美国继续医学教育（CME）学分分为两大类，参加由美国医学会、医学院、专科学会组织的 CME 活动获得的学分为一类学分；由社区医院组织的课程以及参加查房、会诊、自学等所获得的学分一般为二类学分	参加继续教育项目、发表研究论文、参加学术交流会议、参加大学或学会组织的强化课程、讲座等	是
加拿大	每 5 年 1 个周期	每 5 年内至少修满 250 学分	1. 加拿大家庭医生协会负责对家庭医生进行继续职业发展的认证 2. 继续教育课程根据全科医生提出的需求制定，培训内容基于临床证据，如以问题为中心的讨论、同行互评、教学反馈、质量研究等	是
澳大利亚	每 3 年 1 个周期	1. 3 年内至少修满 130 学分 2. 每个全科医生应该至少参加两个“一类活动模块”的活动，并完成“基本心肺复苏技能培训”课程	参加澳大利亚皇家全科医师协会推出的《2017—2019 年质量保障和持续职业发展项目》中的各类项目学习，由协会进行学分认定	是

二、我国全科医学教育

我国全科医学教育发展很不平衡，港澳台地区全科医学教育体系较国内其他地区成熟，20世纪70年代就开始有培养合格的全科医生担任全科医学教师，尝试全科医学理论和临床带教工作，全科医学住院医师培训项目建立较早。我国于20世纪80年代后期引入全科医学的概念，经过不断探索与实践，目前全科医学学科建设逐步走向深入，已经形成较为完善的全科医学教育体系，培养了一定数量的合格全科医学专职教师队伍，建成了一大批全科医生规范化培训基地，全科医生培养标准经过多年的实践与总结，培训内容和培训方式已越来越成熟，尽管在师资队伍、培训基地建设和培养质量方面还存在一定问题，但是，我国全科医学人才培养工作已经在全国广泛开展，截止到2022年底，我国卫生统计年鉴数据显示，我国通过各途径培养的合格全科医生数量已经达到了46.3万人，这些全科医生不仅工作在城市社区卫生服务机构，还工作在边远农村经济欠发达地区的乡镇卫生院、村医室，还有少量的全科医生工作在二、三级综合医院的全科医学科。在这些全科医生队伍中，已经有一批优秀的全科医生成为全科医学教师，在全科医学人才培养工作中发挥着重要作用。

（一）我国全科医学教育发展历程

我国全科医学教育经历从无到有，从起步时的多种模式探索到指导全国全科医生培训规范（大纲）的形成，从规范化培养项目的启动到国家对全科医生队伍建设作出全面规划、全科医师培养与使用激励机制初步建立的不同发展时期。如今我国全科医生职业发展路径清晰，政策利好，全科医学师资队伍数量和质量也在不断提升，全科医生队伍在一定数量的基础上正在往高质量方向发展。

1. 全科医学教育起步和探索阶段 1989年首都医学院（现首都医科大学）率先在全国建立了第一个全科医学教学机构——首都医学院全科医师培训中心，通过举办学术研讨、短期培训等形式传播全科医学概念；在北京、天津、浙江省江山市等地卫生行政部门的支持下，积极进行不同层次和形式的全科医学教学实践，探索全科医生的培养方式。1992年9月，在北京市教育委员会、黑龙江省和浙江省卫生及教育行政部门的支持下，首都医科大学招收了由浙江省江山市卫生局、黑龙江省佳木斯医学院分别选送的7名和23名经过高考录取的临床医学专业本科生，进入首都医科大学临床医学专业全科医学专门化试点班，在全国率先探索在五年制临床医学本科生中培养全科医生的可行性，1997年该试点班培训结束时经专家评估，认为通过五年制医学本科教育不能实现培养合格全科医生的目标。在开设试点班期间，在我国多个省市先后尝试不同形式的全科医学教学，以及全科医疗服务试点工作，开展时间长短不一和内容不同的全科医学师资培训，在当时的环境下，这些教育培训的尝试为全科医学人才培养政策的制定提供了强有力的支持。

1997年，中共中央、国务院《关于卫生改革与发展的决定》颁布，首次在全国提出了要“加快发展全科医学、培养全科医生”，对全科医学教育的发展起到了巨大的推动作用，激发了各地学者、基层卫生保健工作者、卫生服务管理者探索全科医学教育和发展全科医疗服务模式的热情。一些院校的教师、基层医疗服务机构的管理者、卫生行政部门的管理者、基层医生开始主动了解全科医学，针对全科医生和基层全科医疗服务模式开始进行尝试性的研究。

为贯彻落实中共中央、国务院《关于卫生改革与发展的决定》，加快发展我国全科医学教育，1999年12月15日，卫生部颁布《全科医师规范化培训试行办法》（卫科教发〔1999〕第610号），计划“从1999年高等院校医学专业本科毕业生开始实施全科医师规范化培训”，并对培训基地、培训对象、培训目标、培训时间和培训内容进行了明确的规定。同年，卫生部科教司组织专家研究、制定并印发了《全科医师规范化培训大纲（试行）》以及《全科医师岗位培训大纲（试行）》。这是从引进全科医学概念以来，第一次从国家层面印发全科医生的培养标准。随后的1999年12月27日，卫生部召开了全国第一次全科医学教育工作会议。至此，经过政府和前期诸多学者的努力，经过10年的探索与实践，推动了我国全科医学教育从无到有、从多种不成熟培训模式探索并存到国家统一的全科医师培训标

准印发的巨大进步，这也意味着我国全科医学教育工作即将全面启动。这个阶段（1988—2000 年）的全科医学教育称为全科医学教育的起步和探索阶段。

2. 规范的全科医学教育启动与发展阶段　2000 年，各省卫生行政部门开始积极推动本省“全科医师岗位培训”项目的开展，在城市基层医疗机构中陆续有了岗位培训考核合格的全科医生。因受多重因素影响，此时参加全科医师规范化培训的本科毕业生数量极少，只在北京、上海等地启动了“全科医师规范化培训”试点工作。2000 年首都医科大学全科医学培训中心被评为“卫生部全科医学培训中心”，与此相对应的，各省陆续成立了省级全科医学培训中心，随后在（原）卫生部科教司领导下成立以省级培训中心为骨干、卫生部全科医学培训中心牵头的全国全科医学教育培训网络，以推进全国全科医学教育培训工作。2003 年中国医师协会全科医师分会成立，作为全科医生行业组织，在全科医生培养标准、基地建设、教材建设等方面做了大量的建设性工作，如研究制定了《全科医师规范化培训大纲（2017 年版）》；2007 年该协会启动了全科医师规范化培训基地的评估认定工作，共认定国家级全科医生培训基地 34 家，进一步推动了全科医师规范化培训工作。

2005 年教育部支持具有临床一级学科博士点的高等医学院校可以自设二级学科博士学位授权学科和硕士学位授权学科，一些院校陆续启动了全科医学硕士、博士研究生的培养工作。

2006 年教育部《关于加强高等医学院校全科医学、社区护理学教育和学科建设的意见》（教高〔2006〕13 号）印发，对高等医学院校的全科医学学科建设、教学机构建设、课程建设等都有较大的推动作用。随着全科医学教育和全科医生队伍建设相关政策的推进，截止到 2010 年 12 月，我国 128 所高等医学院校中有 46.1%（63 所）的院校开设了全科医学课程，在复旦大学、首都医科大学等 6 所大学中已经开展了全科医学专业硕士和/或博士的研究生培养工作。

随着全科医师岗位培训的开展和全科医生数量逐渐增加，全科医生的继续教育项目也呈现多样化。2010 年，卫生部组织制定了《基层医疗卫生机构全科医生转岗培训大纲（试行）》，规定培训时间不少于 12 个月，提高了对基层全科医生的知识和能力要求。

从 2000 年到 2010 年的十年间，我国全科医生人才培养有了国家级的规范性教学文件，建立了全科医生培训基地标准；全科医学的教材建设、高校中的教学机构建设和课程建设等都得到较大发展，全科医学教育体系逐步建立。在一系列利好政策的支持下，全科医学教育得到了较全面的建设与发展，此阶段可以称为规范的全科医学教育启动与发展阶段。

3. 全科医学教育的快速发展阶段　2011 年 7 月国务院印发的《关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23 号），对我国特色全科医生培养模式作出了顶层设计，确立了我国全科医生培养主流模式为“5+3”培养模式，即前 5 年为临床医学本科教育，后 3 年为全科医生规范化培养。而且根据我国的实际，目前“5+3”全科医生规范化培养可以采取“毕业后规范化培训”和“临床医学专业学位研究生教育”两条路径进行。教育部、卫生部共同印发了有关全科医学专业学位研究生培养与全科专业住院医师培训“接轨”培养的相关政策。在该指导意见中还提出了我国在全科医生制度建设的过渡期内，可以通过全科医学转岗培训和助理全科医生培养来提高全科医生的数量，提升边远农村经济欠发达地区全科医生的水平。

2012 年《全科医生规范化培养标准（试行）》《全科医学师资培训实施意见（试行）》等教学规范陆续印发；2018 年国务院办公厅颁发了《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》，对全科医学学科建设，全科医生队伍建设，全科医学师资队伍建设、教育教学体系建设都起到了极大的促进作用，一些优秀的临床医学本科毕业生开始愿意接受全科专业住院医师培训，优秀的一线全科医生可以进入高等医学院校担任全科医学的教职和研究生导师，有条件的院校成立全科医学学院或者学系；全科医生的继续医学教育项目也丰富多彩；2021 年教育部同意符合条件的高等医学院校进行全科医学专业学位博士研究生培养；全科医生的数量也从 2012 年的 11 万人增长到了 2022 年底的 46.3 万人。可见，从 2011 年《关于建立全科医生制度的指导意见》颁布以来，全科医学教育步入了更加规范和快速发展的新阶段。

（二）我国全科医学教育体系概述

全科医生培养需要有完善的全科医学教育体系支撑。国际全科医学教育实践经验已经证实，完善的全科医学教育体系应包括院校教育、毕业后全科医学教育和全科医学继续教育（即持续职业发展教育）三个教育阶段。我国全科医学教育体系与其他国家一样，也是由以上三个不可或缺的教育阶段组成，每一个教育阶段都承载着不同的全科医生培养任务。

我国医学教育体系具有特定的内涵，如我国目前仍存在临床医学专科教育，研究生培养也与其他国家略有不同，所以我国的全科医学教育体系中，毕业后全科医学教育阶段所承载的全科医学人才培养任务也会与其他国家有所差异。在我国，毕业后全科医学教育阶段，除了承载“5+3”全科专业住院医师培训项目，还承担着全科医学专业型硕士和博士学位研究生培养、“3+2”助理全科医师培训、学术型全科专业硕士和博士研究生培养的任务。可见，我国的毕业后全科医学教育不但承担着培养合格全科医生和助理全科医生的任务，而且承担着培养学术型硕士研究生和博士研究生的任务。此外，我国的继续医学教育也有其特点，我国的全科医生转岗培训虽然也是培养合格全科医生的重要方式之一，但是参加培训者均已经是在临床执业多年的合格临床医生，再通过继续教育的形式，完成 1 年期的全科医生转岗培训达到全科医生的合格标准，获取全科医学执业资格，然后再接受全科医学的继续教育，不断更新知识和技能，提升岗位胜任能力。

近些年来，我国很多高等医学院校，已经建立全科医学教研室或全科医学学系，有条件的院校已经建立全科医学学院，整合当地全科医学优势资源，组建起了高校全科医学师资队伍，大学附属医院作为国家级和省市级全科专业住院医师培训基地，以此为基础，选择并建设一批用于医学生全科医疗实践的基层实践基地。院校全科医学教学机构根据医学生类别、培养方向和未来发展定位的不同，开设课程的学时和内容也有所区别，但多以传授全科医学核心理念和社区全科医疗见习相结合的方式进行课程教学。通过课程教学，临床医学专业学生得以广泛接触全科医疗实践，理解全科医学学科的基本理论和学科特征，了解全科医生队伍在我国卫生保健体系中的重要作用，利于其毕业后选择进入全科医学专业化培训。

我国全科医学继续医学教育已经形成规范的制度化的要求，由中华医学会牵头负责国家级全科医学继续教育项目的设置，各省有专门的机构负责省级全科医学继续教育项目设置和学分管理，并负责监管国家级继续教育项目执行情况。不同地区全科医生参加不同级别的继续教育项目，学分要求也有所不同。对具有中级及中级以上专业技术职务的全科医师，按国家卫生健康委员会有关规定，不断强化对全科医生参加继续医学教育情况的考核，将参加继续医学教育情况作为全科医生岗位聘用、技术职务晋升和执业资格再注册的重要因素。目前，我国全科医学继续教育还处在不断发展的过程中，针对全科医生岗位能力提升和知识技术更新的继续教育项目数量不足，内容欠丰富，还不能很好地满足广大全科医生的学习需求。加强与其他专业协会、专科医师的合作，关注全科医学专业特质，进行继续教育项目开发，兼顾全科医生的个人职业发展需求与兴趣领域，是未来我国全科医学继续教育工作努力的方向。

（三）当前我国全科医学教育培训

1. 院校中全科医学课程教育 我国高等医学院校中的全科医学教育与其他国家一样，是针对医学生的全科医学课程教育，在临床医学专业设置全科医学专业教育。

针对医学生的全科医学课程教育，目前各院校开设情况不一，有的院校是针对全体医学生开设全科医学相关课程，有的院校主要是针对临床医学专业开设全科医学概论等全科医学课程；有的院校课程内容中包含全科医疗见习或者实践教学；课程一般分为必修课和选修课程，有的院校还规定将全科医学概论课程作为医学专业学生的必选课；教学目标多为传授家庭医学的知识、态度和技能，培养学生对全科医疗的职业兴趣，为毕业后接受全科医学规范化培训奠定基础。课程内容主要集中在全科医学学科基本概念、基本理论和基本原则、全科医学人才培养相关政策、全科医生的工作方式、全科医生的临床思维、社区特殊人群保健、社区全科医疗服务见习等方面；教学方式一般采用理论教学与全科医疗见习或实践相结合。目前，各高校尚未做基本的学时要求，一般在 24~48 学时之间，有些院校

针对临床医学专业的农村订单定向医学生，会安排更多课时。

教育部高等学校医学人文素养与全科医学教学指导委员会对全国 175 所高等医学院校调查结果显示：截止到 2019 年，我国 175 所高等医学院校中，有 45 所（25.7%）成立了全科医学学院/学系，64.0% 的院校建立了全科医学教研室，有 108 所（61.7%）高校拥有本科生基层教学实践基地，143 所（81.7%）高校开设了全科医学课程，其中 121 所（69.1%）开设的是全科医学必修课。

2. 全科专业住院医师规范化培训　全科专业住院医师规范化培训，在以前的文件中又称为全科医师规范化培训，是我国毕业后全科医学教育项目之一，也是培养全科医生的重要途径之一。我国全科医师规范化培训，始于 1999 年 12 月卫生部颁布《全科医师规范化培训试行办法》（卫科教发〔1999〕第 610 号）和《全科医师规范化培训大纲（试行）》。2006 年卫生部科教司委托中国医师协会制定各专科医师的培养标准，全科医学分会组织专家在原来《全科医师规范化培训大纲（试行）》的基础上，对培训时长和培训内容进行充分论证和调整，印发了《全科医师规范化培训大纲（2007 年版）》，培训的总时长由最开始制定的 4 年，修订为 3 年。2012 年在前期培训大纲的基础上，为了适应新时期全科医生队伍建设的需要，组织专家研究制定了《全科住院医师培训标准（试行）》，在 2019 年制定了 2019 年版的《全科住院医师培训标准（试行）》；后又对 2019 年版的相关内容再一次进行讨论和完善。目前，各地培训中使用的《全科培训细则》来自中国医师协会于 2022 年 8 月发布的《住院医师规范化培训内容与标准（2022 年版）》。综上，从 2012 年开始我国的“全科医师规范化培训”的称谓，改为“全科专业住院医师规范化培训”，培养大纲也演变为“全科住院医师培训标准”和“全科培训细则”。

2015 年以来，全科专业住院医师规范化培训年度招录人数开始比以前有较大幅度增长，年度招录人数能够达到 5 000 人左右，最近几年达到 1 万人左右，参加项目的住院医师主要来源于高校新毕业的农村订单定向免费医学生。此外，还有少量的全科医学专业型硕士学位研究生。

（1）培训目标：成为合格的全科医师。力争达到强临床、懂公卫、识中医、能教学、晓研究、善管理、在城乡基层条件下具备独立行医及进行健康管理的能力。

（2）培训时间：培训总时间为 3 年。3 年中，全科医疗实践共 10 个月，3 个月安排在临床基地全科医学科，7 个月安排在基层实践基地；其他临床科室轮转培训 23 个月；选修内容 3 个月。

（3）培训方式：培训方式包括多种形式的理论学习、全科医疗实践及其他临床科室轮转培训。

在 3 年培训过程中，以能独立承担全科医生岗位工作为主线，以分层递进的方式进行培养，年度能力培养要求见表 2-2。

表 2-2　全科专业住院医师规范化培训分层递进培养的安排与要求

培训年度	年度能力培养要求
第 1 年	以跟随指导医师门诊、管理病床、出诊等方式，系统学习处理全科医学核心问题的诊疗技能，重点掌握常见病、多发病诊治，以及基层医疗卫生工作的特点（如服务内容、服务方式、沟通方法等）。在上级医师指导下不断提高全科临床诊疗能力；参与指导医师在基层实践基地的全科工作
第 2 年	采取指导医师监督指导方式，使全科专业住院医师掌握全科医生的临床思维模式和接诊技巧等，横向拓展相关专业临床技能，奠定扎实的临床医疗工作基础；在上级医师指导下完成基层实践基地的全科工作
第 3 年	通过向指导医师请教重点问题、疑难问题，参与科研及低年资住院医师教学等，使全科专业住院医师掌握基层医疗卫生服务主要内容，具备全科医生的独立接诊能力、团队服务与协调管理能力、基本教学与终身学习能力、科研素养和健康素养等；独立完成基层实践基地的全科健康管理工作

（4）培训内容和要求，详见中国医师协会网站中的《住院医师规范化培训内容与标准（2022 年版）》中的《全科培训细则》。

（5）培训基地：培训安排在省级卫生行政部门认定的全科专业住院医师规范化培训基地进行，通常这些基地为二级甲等及以上级别的综合医院和当地优质社区卫生服务中心。

（6）考试与考核：培训考核分为培训过程考核和结业考核。住院医师完成全部培训内容并且过

程考核合格，才可以申请参加全科专业住院医师规范化培训结业考核（包括临床技能考核和综合理论书面考试）。结业考试合格后由省级卫生行政部门颁发全科专业住院医师规范化培训合格证书。此证书是从事全科医疗服务时注册全科医疗执业范围的凭证。

3. 助理全科医生培训项目 我国医学教育体系与其他西方国家不同，到目前为止我国高等医学院校中仍有临床医学专科教育。2012 年，卫生部、教育部组织专家研究、制定并印发了《助理全科医生培训标准（试行）》。该培养标准是在我国全科医生制度建立过程中针对欠发达农村地区的全科医生队伍建设而建立的培训项目规范。北京按照本标准率先启动了助理全科医生培训工作，其他省份于 2016 年正式启动该培训项目。2019 年由中国医师协会全科医师分会组织专家对该培训标准进行完善，并于 2020 年印发了《助理全科医生培训标准（2020 年版）》。助理全科医生培训项目，是我国特殊医学教育体系下毕业后全科医学教育的特殊形式。

（1）培训对象：临床医学专业三年制专科毕业，拟在或已经在农村基层医疗卫生机构从事全科医疗工作的人员。

（2）培训目标：成为热爱我国医疗卫生事业，能够胜任助理全科医生岗位的合格助理全科医生。

（3）培训时间和培训方式：助理全科医生培训年限为 2 年。对于因特殊情况不能按期完成培训者，可申请适当延长培训时间，具体延长时间由各省自行把握。其中，临床培训 82 周，安排在认定的临床培养基地进行；基层实践 16 周，安排在认定的基层实践基地进行；理论和综合素质课程采取集中与分散相结合的方式进行。

（4）培训基地：省级有关部门负责培训基地的认证；临床培养基地以有条件的二级综合医院为主，基层实践基地应选择有条件的乡镇卫生院、社区卫生服务中心和专业公共卫生机构；综合素质和职业相关能力培养的课程可由相关高等医学院校承担。

（5）培训内容及要求，具体详见中国医师协会组织修订的《助理全科医生培训标准（2020 年版）》

（6）培训招收与考核：各省级卫生行政部门负责组织实施本地区的助理全科医生培训招收与考核工作。培训考核实行过程考核与结业考核相结合，过程考核由培训基地负责实施，结业考核由省级卫生行政部门统一组织，结业考核包括综合理论考核和临床技能考核，省级卫生行政部门对结业考核成绩合格者，颁发统一制式的《助理全科医生培训合格证书》。近几年来，国家卫生健康委人才交流服务中心根据各地的需求，组织助理全科医生培训结业理论考核，有需要的地区则组织培训过程考核合格的助理全科医生学员参加此考试。

4. 全科医学研究生教育项目 我国全科医学研究生培养的学位类型分为学术型和专业型两个类别。在我国，复旦大学最早于 2003 年开始开展全科医学专业型硕士学位研究生培养。自 2004—2005 年国务院学位办允许在临床一级学科博士学位授权学科下自主设置二级学科学位点，一些院校论证和备案成功，其中，首都医科大学于 2005 年开始招收第一批学术型博士学位研究生，成为全国最早开展全科医学博士研究生培养的高校。2011 年国务院学位办在临床医学专业学位类别下增设了全科医学和临床病理学领域研究生教育，推动了全科医学研究生教育的开展，至今，我国已经有 100 多所高等医学院校具备招收全科医学研究生的资质。为落实 2011 年国务院印发的《关于建立全科医生制度的指导意见》精神，2012 年一些院校开始招收全科医学专业型硕士学位研究生，并与“全科专业住院医师规范化培训”进行“并轨”培养，即全科医学领域常说的“四证合一”培养模式，即全科医学专业型硕士学位研究生通过三年的培养，可以取得硕士研究生学历证书、硕士学位证书、全科专业住院医师规范化培训合格证书、临床执业医师资格证书。2014 年教育部等六部门《关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见》的印发，进一步推进了“全科专业住院医师规范化培训”反向并轨的工作，即对于接受全科专业住院医师规范化培训的住院医师，如果想获得硕士研究生学位，则可在培训基地医院隶属的高等医学院校参加相关课程学习和学术培养，培养过程考核合格且论文答辩通过后，可以申请获得专业型硕士学位。

教育部高等学校医学人文素养与全科医学教学指导委员会对全国 175 所高等医学院校调查结果

NOTES

显示：截止到 2019 年，我国 175 所医学院校中共有 78 所拥有全科医学硕士研究生招生点。2021 年教育部同意有条件的高等医学院校开展全科医学专业型博士学位研究生培养，目前已有多所院校已经开展了此项工作。

（1）学术型硕士研究生培养：学制为 3 年，培养目标主要是在广泛学习全科医学学科相关知识的基础上，侧重于研究方法、研究能力和论文撰写能力的培养，培训结束时，应该掌握全科医学常用的研究方法，能够独立完成课题设计与实施、数据处理与研究报告撰写。在培养细节上，不同院校对研究生培养有不同的要求，导师的研究方向和具体的研究课题，都会对研究生在三年培养中是否有更多时间进行临床实践有一定影响。目前，此类研究生培养的数量不多。

有省份针对基层在岗全科医生开放学位申请，通过在职攻读硕士学位的方式，利用业余时间进行课程学习和课题研究，最后获得学术型硕士学位。

（2）专业型硕士研究生培养：学制为 3 年，由于目前各院校都实行与全科专业住院医师规范化培训“并轨”培养的模式，故其培养目标定位是培养具有一定研究能力的合格全科医生，将研究能力和临床服务能力培养放在同等重要的地位。3 年培训时间里，因为要完成《全科培训细则》中各项内容学习，并要求在 3 年中必须通过执业医师资格考试，所以用于科学研究的时间相对较少，多是利用业余时间来完成科研训练。基于此，各院校对该类研究生的毕业论文要求存在很大差别，有的院校要求公开发表论文，但更多院校要求只完成学术培养过程和研究报告，或者撰写综述论文即可毕业。目前国内对该项目存在一定的争议，但是在基层医疗机构就业的毕业生却受到了用人单位的欢迎。

（3）学术型博士研究生培养（简称“科博培养”）：学制 3 年。目前国内招收此类型博士研究生数量较少，生源也很少来自基层全科医生队伍。该培训项目的定位是为全科医学学科培养学术骨干或潜在的学术带头人。毕业时一般要求具有较强的研究能力，对全科医学某领域有较深入的研究，能够发表具有创新性的研究成果。从目前毕业生的就业调查结果看，一般都能在本专业就业，并能发挥学术骨干的作用。

（4）专业型博士研究生培养（简称“专博培养”）：学制 3 年。目前该培养项目的定位在业界还没有达成一致，各单位的培养方案在培养内容、学术培养和临床实践的时间分配上均有很大不同。这对申请该项目的学生来说，需要认真审视求学目的与学校专博培养方案所确定培养目标的吻合程度。2021 年全科专博培养项目开始在多所院校中招生，为专硕毕业生提供了深造的新机遇，也为想发展某项临床服务专长的全科医生开辟了一条新的学习路径。

5. 全科医生转岗培训项目　全科医生转岗培训项目是我国培养合格全科医生的重要途径之一。为加强我国基层卫生人才培养，贯彻《以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设规划》（发改社会〔2010〕561 号），原卫生部组织制定了《基层医疗卫生机构全科医生转岗培训大纲（试行）》并于 2011 年 1 月印发。从 2011 年针对基层医疗卫生机构临床医生的全科医生转岗培训项目在全国全面启动。此后，为贯彻落实国务院办公厅《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》要求，扩大全科医生转岗培训实施范围，国家卫生健康委组织专家制定了《全科医生转岗培训大纲（2019 年修订版）》，并于 2019 年 4 月印发，目前全国的转岗培训使用的是此版培训规范。

（1）培训目标：合格全科医生。

（2）培训对象：①基层医疗卫生机构中已取得临床执业（助理）医师资格的临床执业（助理）医师。②二级及以上医院中取得临床执业医师资格即符合相关条件的其他专业临床执业医师。从培训对象来看，转岗培训的对象已经扩展到了我国二、三级综合医院的临床执业医师的范畴。

（3）培训时间：培训总时长为 12 个月，可在 2 年内完成。其中，全科医学基本理论知识培训不少于 1 个月（160 学时），临床综合诊疗能力培训不少于 10 个月，基层医疗卫生实践不少于 1 个月（160 学时）；全科临床思维训练时间不少于 20 学时，可穿插于培训全过程。

（4）培训方式：培训采取必修与选修模块相结合的方式进行，根据培训对象的专业背景和临床工作背景，按照“填平补齐”的原则，以全科岗位胜任能力的培养为导向，灵活安排培训内容。

（5）培训内容和要求：详见《全科医生转岗培训大纲（2019 年修订版）》。

6. 全科医学师资培训 从全科医学概念引入到2012年之前，我国全科医学师资培训没有统一的规范。2012年12月，为贯彻落实国务院《关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号），加强全科医学师资队伍建设，保证全科医生培养质量，卫生部、教育部、财政部和国家中医药局组织制定了《全科医学师资培训实施意见（试行）》并印发全国，从此我国的全科医学师资培训也走入规范化。

（1）培训对象：以临床师资和基层实践师资为重点，分为临床师资、基层实践师资、全科医学理论培训教师。对于拟成为临床师资的临床医生，要求具备本科及以上学历、主治医师及以上专业技术职称，具有较丰富的临床医疗和临床教学经验等条件。基层实践师资需要具备大学专科及以上学历、中级及以上专业技术职称，基层临床医疗和相关公共卫生服务经验丰富等条件。全科医学理论培训教师要求由熟悉全科医学理论和具有授课能力的临床师资、基层实践师资承担，高等医学院校相关专业教师也纳入理论师资培训的范畴。

（2）培训内容：培训内容主要包括全科医生培养工作的重要意义和相关政策制度、全科医学师资的职责和主要任务、全科医学理念、全科医疗卫生服务技能及其特点、全科医学思维以及全科医学指导、带教方法等。针对以上三类师资在培训中的功能定位不同，提出了具体需要掌握的知识和技能要求。

临床师资：树立全科医学理念，熟悉基层全科医生服务的内容、方式与特点，掌握全科医生培养中临床指导、带教的内容和方法，能结合本专科实际正确指导、带教，帮助全科医生巩固专业思想并掌握相关业务技术技能。基层实践师资着重加强全科医生指导、带教基本理论知识和具体技能方法的培训，理解、掌握全科医生培养标准、教学大纲，胜任基层指导、带教工作，规范指导、带教行为。承担理论培训的师资还应掌握全科医学和公共卫生相关理论，并能够紧密结合全科医生基层医疗卫生服务实践予以正确阐述。骨干师资还应掌握全科医学培训体系设计、全科医学师资培训的基本理论和方法，指导、帮助全科医学师资热爱全科医生培养工作，掌握正确的指导、带教方法，培养合格全科医生。随着全科医生队伍建设的不断推进，临床培训基地全科医学师资和基层实践基地承担师资职能的全科医生的素质能力逐步实现同一。

（3）培训时间与方式：培训总时长不少于2个月，其中，集中培训时间不少于56学时，基层实践师资培训时间可根据实际需要适当延长。培训可以采取集中学习与分散自学相结合、面授与远程培训相结合、教学示范与教学实践相结合、课堂教学与现场考察相结合等多种方式进行。

（4）培训考核与管理：省级卫生行政部门负责组织实施本地区的师资培训考核工作，对完成全科医学师资培训、考试合格者，颁发全科医学师资培训合格证书。国家卫生健康委员会、国家中医药管理局负责组织实施全国骨干师资培训与考核工作，对完成培训、考试合格者，颁发全科医学骨干师资培训合格证书，中国医师协会和各省相关部门对骨干师资和省级师资实行动态管理。

（路孝琴）

思考题

1. 全科医生在其服务中应该遵循哪些基本原则？
2. 全科医学“以病人为中心照顾”的原则在实际中体现在哪几个方面？
3. 请阐释你对全科医学连续性服务的理解。
4. 我国全科医学教育体系所承载的项目与国外有哪些不同？

思考题解题思路　本章目标测试　本章思维导图